DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

IDENTIFICACIÓN

Paciente: MARIA IRMA MORALES AGUDELO **Identificación** CC 31407743
Edad: 64 AÑOS **Empresa:** NUEVA EPS SA SUBSIDIADO 2025
Sala: QUIROFANO 2 **Fecha programación de cirugía:** 03/11/2026

Sede de Atención: SEDE PRINCIPAL

CIRUGÍAS

CANT	CÓDIGO	NOMBRE DE LA CIRUGÍA	Grupo Quirúrgico	UVR
1	**042325**	**NEUROLISIS DE OTRO NERVIO PERIFERICO VIA ABIERTA**	Y47	

Cirujano: CRISTIAN CAMILO GUTIERREZ GASPAR **Especialidad:** ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Vía: ANTEBRAZO DERECHO

1	**770302**	**SECUESTRECTOMIA, DRENAJE, DESBRIDAMIENTO DE RADIO Y CUBITO**	Y39	

Cirujano: CRISTIAN CAMILO GUTIERREZ GASPAR **Especialidad:** ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Vía: ANTEBRAZO DERECHO

2	**780301**	**INJERTO ÓSEO EN CÚBITO O RADIO**	Y41	

Cirujano: CRISTIAN CAMILO GUTIERREZ GASPAR **Especialidad:** ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Vía: ANTEBRAZO DERECHO

1	**793306**	**REDUCCION ABIERTA DE FRACTURA EN SEGMENTO DISTAL DE RADIO Y CUBITO CON FIJACION INTERNA**	Y41	

Cirujano: CRISTIAN CAMILO GUTIERREZ GASPAR **Especialidad:** ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Vía:

1	**798302**	**REDUCCION DE LUXACION RADIOCUBITAL VIA ABIERTA**	Y39	

Cirujano: CRISTIAN CAMILO GUTIERREZ GASPAR **Especialidad:** ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Vía: ANTEBRAZO DERECHO

2	**824215**	**TENORRAFIA DE FLEXORES DE MANO (UNO O MAS) SIN NEURORRAFIA**	Y45	

Cirujano: CRISTIAN CAMILO GUTIERREZ GASPAR **Especialidad:** ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Vía: ANTEBRAZO DERECHO

2	**829125**	**TENOLISIS EN FLEXORES DE MANO (UNO O MAS)**	Y43	

Cirujano: CRISTIAN CAMILO GUTIERREZ GASPAR **Especialidad:** ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Vía: ANTEBRAZO DERECHO

DESCRIPCIÓN CIRUGÍA

CIRUJANO ES254 CRISTIAN CAMILO GUTIERREZ GASPAR **Especialidad** ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA

042325 **NEUROLISIS DE OTRO NERVIO PERIFERICO VIA ABIERTA**
770302 **SECUESTRECTOMIA, DRENAJE, DESBRIDAMIENTO DE RADIO Y CUBITO**
780301 **INJERTO ÓSEO EN CÚBITO O RADIO**
793306 **REDUCCION ABIERTA DE FRACTURA EN SEGMENTO DISTAL DE RADIO Y CUBITO CON FIJACION INTERNA**
798302 **REDUCCION DE LUXACION RADIOCUBITAL VIA ABIERTA**
824215 **TENORRAFIA DE FLEXORES DE MANO (UNO O MAS) SIN NEURORRAFIA**
829125 **TENOLISIS EN FLEXORES DE MANO (UNO O MAS)**

Dx Preoperatorio: S526 FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL CUBITO Y DEL RADIO

Dx Postoperatorio: S526 FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL CUBITO Y DEL RADIO

Tipo de Herida: LIMPIA **Tipo de Anestesia:** BLOQUEO NERVIO **Tipo de Cirugía:** PROGRAMADA
Cantidad de Sangrado: 0 **ml.** **Vía:** UNICA VIA
Clasificación de riesgo quirúrgico : **A.S.A :** 0 **NNIS :** 0
Realización Acto Quirúrgico: **Fecha Inicio** 03/11/26 **Fecha Final** 03/11/26
Hora Inicio 09:00:00 **Hora Final** 10:30:00
Tiempo de Perfusión: 0 **Minutos** **Tiempo de Clamp:** 0 **Minutos**

Descripcion Quirúrgica:
PACIENTE EN DECUBITO SUPINO, PREVIA PAUSA DE SEGURIDAD, VERIFICACION DE LATERALIDAD Y CONSENTIMIENTO INFORMADO FIRMADO, ANESTESIA , ASEPSIA Y ANTISEPSIA, COLOCACION DE CAMPOS ESTERILES, SE PROCEDE A IDENTIFICAR HALLAZGOS: ANTEBRAZO DERECHO CON DOLOR, EDEMA Y DEFORMIDAD, LIMITACION PARA LA FLEXO

DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

EXTENSION Y PRONOSUPINACION POR DOLOR, NO SINDROME COMPARTIMENTAL, PULSOS RADIAL Y CUBITAL NORMALES, LLENADO CAPILAR NORMAL , EVALUACION DE AREAS AUTONOMAS DE LA MANO CON PARESTESIAS EN TERRITORIO DEL MEDIANO Y RADIAL , LIMITACION PARCIAL PARA EXTENSION DE MUÑECA Y DEDOS , INTRAOPERATORIAMENTE LUXACION DE ARTICULACION RADIOCUBITAL DISTAL , SOLUCION DE CONTINUIDAD QUE COMPROMETE EL 80% DEL ESPESOR DEL FLEXOR CARPI RADIALIS Y 80% DEL ESPESOR DEL FLEXOR CARPI ULNARIS, NERVIO MEDIANO INCLUIDO EN FOCO DE FRACTURA DE RADIO CON MODERADA CONTUSION.
ABORDAJE #1: SE PROCEDE A REALIZAR ABORDAJE DE HENRY EN ANTEBRAZO DERECHO, DISECCION SUPERFICIAL Y PROFUNDA POR PLANOS, SE IDENTIFICA FLEXOR CARPI RADIALIS INCLUIDO EN FOCO DE FRACTURA CON SOLUCION DE CONTINUIDAD QUE COMPROMETE EL 80% DE SU ESPESOR, SE PROCEDE A RETIRAR TEJIDO INTERPUESTO DE FOCO DE FRACTURA , SE IDENTIFICA TRAZO Y CONMINUCION MODERADA CON FRAGMENTOS OSEOS LIBRES NO ADHERIDOS A TEJIDOS BLANDOS, NERVIO MEDIANO INCLUIDO EN FOCO DE FRACTURA DE RADIO CON MODERADA CONTUSION REALIZANDOSE NEUROLISIS DEL NERVIO MEDIANO Y RETIRANDO DE CAMPO QUIRURGICO Y PROTEGIENDOLO EN TODO MOMENTO , SE REALIZA LAVADO MAS DESBRIDAMIENTO Y SECUESTRECTOMIA DE FOCO DE FRACTURA EN RADIO RETIRANDO HUESO NO VITAL , SE PROCEDE A REDUCIR BAJO VISION DIRECTA MANTENIENDO REDUCCION TRANSITORIAMENTE CON PINZAS, SE POSICIONA PLACA Y FIJA CON TORNILLOS CORTICALES Y BLOQUEADOS GARANTIZANDO MINIMO 6 CORTICALES POR SEGMENTO , SE RETIRAN PINZAS REDUCTORAS Y CON FLUOROSCOPIA SE VERIFICA MANTENIMIENTO DE REDUCCION Y POSICION DE HARWARE CONSIDERANDOSE ADECUADA, SE REALIZA VENTANA METAFISIARIA LATERAL EN RADIO DISTAL Y COSECHAN 3 CC DE HUESO ESPONJOSO LOS CUALES SE IMPACTAN EN FOCO DE FRACTURA A MODO DE AUTOINJERTO OSEO MINIMIZANDO GAP Y PERDIDA OSEA , SE LAVA , SE CORROBORA HEMOSTASIA Y PROCEDE A TENOLISIS DE CABOS PROXIMAL Y DISTAL DEL TENDON Y POSTERIOR TENORRAFIA DE FLEXOR CARPI RADIALIS CON SUTURA ABSORBIBLE CON PUNTOS TIPO KESSLER, SE VERIFICA ESTABILIDAD DE RECONSTRUCCION Y ADECUADA EXCURSION DEL TENDON, SE CIERRA POR PLANOS HASTA PIEL
ABORDAJE #2: SE REALIZA ABORDAJE QUIRURGICO SOBRE EJE DIAFISIARIO DEL CUBITO DERECHO, DISECCION SUPERFICIAL Y PROFUNDA POR PLANOS , SE IDENTIFICA SOLUCION DE CONTINUIDAD QUE COMPROMETE EL 80% DEL ESPESOR DEL FLEXOR CARPI ULNARIS , DISECCION SUPERFICIAL Y PROFUNDA POR PLANOS, SE IDENTIFICA FOCO DE FRACTURA CONMINUTO EN CUBITO DISTAL Y PROCEDE A REALIZAR LAVADO MAS DESBRIDAMIENTO Y SECUESTRECTOMIA DEL MISMO RETIRANDO HUESO NO VITAL, SE REALIZA REDUCCION DE FOCO DE FRACTURA BAJO VISION DIRECTA, SE POSICIONA PLACA Y PROCEDE A FIJAR CON TORNILLOS CORTICALES Y BLOQUEADOS, SE REALIZA VENTANA METAFISIARIA LATERAL EN CUBITO DISTAL Y COSECHAN 2 CC DE HUESO ESPONJOSO LOS CUALES SE IMPACTAN EN FOCO DE FRACTURA A MODO DE AUTOINJERTO OSEO MINIMIZANDO GAP Y PERDIDA OSEA , SE LAVA , SE CORROBORA HEMOSTASIA Y REALIZA TENOLISIS DE CABOS PROXIMAL Y DISTAL DEL TENDON Y POSTERIOR TENORRAFIA DE FLEXOR CAPI ULNARIS CON SUTURA ABSORBIBLE EN DOBLE FILA , SE REDUCE ARTICULACION RADIOCUBITAL LUXADA Y FIJA CON CLAVO DE KIRSCHNER , SE CIERRA POR PLANOS HASTA PIEL, PROCEDIEMIENTO SIN COMPLICACIONES INMEDIATAS , TRASLADO A RECUPERACION.
MATERIALES:
. PLACA 2 COLUMNAS VA LCP 2.4 P / RAD DIS PALMAR DERECHA #1
. PLACA LCP DE 2.4 EN L P / RAD DIS DORSAL DERECHA #1
. TORNILLO BLOQUEADO VA 2.4 AUTORROSCANTE X 14 #2
. TORNILLO CORTICAL DE 2.4 AUTORROSCANTE X 14 #1
. TORNILLO CORTICAL DE 2.4 AUTORROSCANTE X 16 #1
. TORNILLO BLOQUEADO 2.4 AUTORROSCANTE X 14 #4
. TORNILLO BLOQUEADO 2.4 AUTORROSCANTE X 18 #4
. AGUJA K DE 1.6 C 150 MM #1

Complicaciones : **SI** ☐ **NO** ☒

Hallazgos :

ANTEBRAZO DERECHO CON DOLOR, EDEMA Y DEFORMIDAD, LIMITACION PARA LA FLEXO EXTENSION Y PRONOSUPINACION POR DOLOR, NO SINDROME COMPARTIMENTAL, PULSOS RADIAL Y CUBITAL NORMALES, LLENADO CAPILAR NORMAL , EVALUACION DE AREAS AUTONOMAS DE LA MANO CON PARESTESIAS EN TERRITORIO DEL MEDIANO Y RADIAL , LIMITACION PARCIAL PARA EXTENSION DE MUÑECA Y DEDOS , INTRAOPERATORIAMENTE LUXACION DE ARTICULACION RADIOCUBITAL DISTAL , SOLUCION DE CONTINUIDAD QUE COMPROMETE EL 80% DEL ESPESOR DEL FLEXOR CARPI RADIALIS Y 80% DEL ESPESOR DEL FLEXOR CARPI ULNARIS, NERVIO MEDIANO INCLUIDO EN FOCO DE FRACTURA DE RADIO CON MODERADA CONTUSION.

Tejidos enviados a patología : **SI** ☐ **NO** ☒

OTROS PARTICIPANTES

CÓDIGO	NOMBRE	TIPO
ES186	MARIO GERMAN OROZCO SANDOVAL	ANESTESIOLOGO
ES254	CRISTIAN CAMILO GUTIERREZ GASPAR	ESPECIALISTA
MG221	OSCAR MARINO RIOS MEJIA	AYUDANTE

DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS



CRISTIAN CAMILO GUTIERREZ GASPAR
Reg. 76143512
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA

*** * * FIN DEL REPORTE * * ***